DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2025.05.005

·康复教育·

高等职业院校言语听觉康复技术专业校内实训室建设研究

易玲[1]，周静[1]，梁永胜[2]，陈雪芬[3]，曹艳静[4]

1. 宁波卫生职业技术学院，浙江宁波市315100；2. 山东特殊教育职业学院，山东济南市250000；3. 宁波市鄞州区小小虎特殊儿童康复训练中心，浙江宁波市315100；4. 长沙民政职业技术学院，湖南长沙市410004

通信作者：周静，E-mail：15205746327@qq.com

基金项目：1. 健康宁波研究基地项目(No. JD6-329)；2. 中国职业技术教育学会职业教育科研课题重点项目(No. SZ24A28)；3. 山东省职业教育教学改革研究项目(No. 20240499)

摘要

目的 从构建现代职业教育体系和建立专业胜任力导向的教育体系出发，系统探讨高等职业院校言语听觉康复(SHR)专业校内实训基地的建设相关问题，分析校内实训基地的功能定位及其核心构成要素；基于世界卫生组织康复胜任力架构(RCF)和专业教育标准，构建一个以胜任力为导向、模块化的校内实训模式。

方法 采用高等职业教育理论、实践教学理论(如情境学习、体验学习、建构主义)，在分析国内外SHR教育的相关政策和技术文件基础上，从发展完善高等职业教育角度分析校内实训基地的战略意义以及构成要素(硬件、软件、人力、管理)。参照RCF，并整合美国言语语言听力协会(ASHA)的知识和能力获取(KASA)表、国际言语治疗和语音学协会(IALP)的教育指南以及中国教育部《高等职业学校专业教学标准》，识别并构建适用于高等职业层次的SHR专业核心胜任力模型。基于该胜任力模型，设计模块化的校内实训内容体系以及实训教学的多种模式。

结果 校内实训基地是高等职业SHR教育体系中连接理论与实践、促进“教-学-做”一体化的关键平台。实训基地建设涵盖硬件设施(满足专业特殊声学与设备要求)、软件资源(含教学案例库、标准化操作流程、数字化资源)、“双师型”人力资源以及科学管理体系(含运行、评价、产教融合机制) 4个领域。基于RCF及相关标准的分析，构建包含专业基础与伦理、听力评估、听力康复与技术、言语语言评估、言语语言干预、沟通与协作等维度的SHR核心专业胜任力。在此基础上，设计了8大核心实训模块：听力检测基础操作、客观听力检测入门、助听器验配初步、标准化言语语言评估工具应用、构音与嗓音障碍评估与干预模拟、吞咽障碍筛查与基础训练模拟、综合案例分析与康复计划制定、职业素养与沟通技能演练。每个模块均明确能力目标、核心活动、资源需求，并强调其必须与理论课程教学、校外专业实践(实习)的内容与时序紧密协同，形成“课程-实训-实习”一体化的人才培养路径。进一步提出相关的教学模式，如问题导向学习、案例教学法、模拟教学、项目导向学习、翻转课堂等。

结论 高等职业院校SHR专业校内实训基地建设的核心在于构建一个以专业胜任力为导向的系统化实践教学环境。本研究基于RCF以及言语听觉领域的知识、技能与能力内容，设计了8大核心实训模块，并提出与之配套的多元化教学模式、策略，为高等职业院校SHR专业校内实训基地的内涵建设提供了一套具有理论支撑和实践指导意义的综合方案。校内实训基地的建设，必须重视硬件、软件、人力、管理四要素的协同发展，并确保实训内容与课程、实习的深度融合，通过创新的教学方法激发学生潜能，通过科学的评估促进学生全面发展。

关键词 言语听觉康复技术；校内实训基地；专业胜任力；实训模块

Developing on-campus training bases for speech and hearing rehabilitation programs in higher vocational colleges

YI Ling[1], ZHOU Jing[1], LIANG Yongsheng[2], CHEN Xuefen[3], CAO Yanjing[4]

1. Ningbo College of Health Sciences, Ningbo, Zhejiang 315100, China; 2. Shandong Vocational College of Special Edu-

作者简介：易玲(1988-)，女，汉族，四川广安市人，硕士，讲师，主要研究方向：言语语言功能康复、ICF。通信作者：周静，女，汉族，浙江宁波市人，硕士，教授，主要研究方向：儿童言语语言康复、教育康复、ICF。

中国知网 https://www.cnki.net

cation, Ji'nan, Shandong 250000, China; 3. Ningbo Yinzhou District Little Tiger Special Children Rehabilitation Training Center, Ningbo, Zhejiang 315100, China; 4. Changsha Social Work College, Changsha, Hunan 410004, China

Correspondence to *ZHOU Jing,* E-mail: 15205746327@qq.com

Supported by Healthy Ningbo Research Center Project (No. JD6-329), China Vocational Education Association Programe in Vocational and Technical Education (Key) (No. SZ24A28) and Shandong Provincial Vocational Education Teaching Reform Research Project (No. 20240499)

Abstract

Objective Responding to the imperative to modernize vocational education and establish competency-oriented systems, this study investigates the development of on-campus training bases for speech and hearing rehabilitation (SHR) programs within Chinese higher vocational colleges (HVC). It analyzes their functional role and essential components, and propose a competency-oriented, modular framework for on-campus training based on World Health Organization (WHO) rehabilitation competency framework (RCF), and professional education standards.

Methods This research synthesized theories of higher vocational education and practical pedagogy (e.g., situated learning, experiential learning and constructivism) with analyses of domestic and international SHR educational policies and standards. It examined the strategic importance and essential components (hardware, software, human resources, management) of on-campus training bases in the context of higher vocational education. Synthesizing RCF with standards from ASHA (knowledge and skills acquisition, KASA), International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP), and Teaching Standards for Higher Vocational Schools from Ministry of Education of the People's Republic of China, a core SHR professional competency model tailored for HVC was developed. This model subsequently guided the design of a modular on-campus training curriculum and associated pedagogical approaches.

Results On-campus training bases were pivotal platforms that bridge theory and practice, facilitating 'teaching-learning-doing' integration within HVC SHR programs. Effective base construction necessitated synergistic integration across four key domains: hardware facilities (meeting specialized acoustic/equipment needs), software resources (case libraries, standard operating procedure and digital tools), 'dual-role' human resources and robust management systems (operations, evaluation, industry-education linkages). Derived from RCF and related standards, a core SHR competency framework was developed, encompassing dimensions such as foundational knowledge and ethics, assessment (audiological; speech-language), intervention (audiological rehabilitation and technology; speech-language), and communication and collaboration. Consequently, eight core training modules were designed, including basic operations of hearing testing, introduction to objective hearing testing, preliminary hearing aid fitting, application of standardized speech-language assessment tools, simulation of articulation and voice disorder assessment and intervention, simulation of swallowing disorder screening and basic training, comprehensive case analysis and rehabilitation plan development, and practice of professional literacy and communication skills; detailing objectives, activities, and resources, and intended for seamless integration with theoretical courses and off-campus practicum, establishing a cohesive 'curriculum-training-practicum' continuum. Furthermore, a suite of adaptable pedagogical models, including problem-based learning, case-based learning, simulation-based training, project-based learning and the flipped classroom, were recommended for implementing these modules.

Conclusion The effective development of on-campus training bases for SHR programs in HVC necessitates establishing a systematic, competency-oriented practical teaching environment. Grounded in RCF, and essential SHR knowledge, skills and abilities, this study proposes a framework incorporating eight core training modules and complementary pedagogical models, providing a theoretically grounded, practically applicable blueprint for enhancing the educational quality and substance of these bases within HVC. Successful realization hinges upon the synergistic development of the four key elements (hardware, software, human resources, management), deep integration between training activities, the curriculum, and practicum experiences, and the application of innovative pedagogy to cultivate student potential.

Keywords: speech and hearing rehabilitation; on-campus training base; professional competency; training module

中国知网 https://www.cnki.net

[中图分类号] R49-4 [文献标识码] A [文章编号] 1006-9771(2025)05-0529-10
[本文著录格式] 易玲,周静,梁永胜,等. 高等职业院校言语听觉康复技术专业校内实训室建设研究[J]. 中国康复理论与实践, 2025, 31(5): 529-538.
CITED AS: YI Ling, ZHOU Jing, LIANG Yongsheng, et al. Developing on-campus training bases for speech and hearing rehabilitation programs in higher vocational colleges [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2025, 31(5): 529-538.

0 引言

随着全球人口老龄化趋势加剧、新生儿听力筛查普及以及社会对生活质量要求的提高，言语、语言、听力及吞咽障碍的康复需求日益增长[1]。

言语听觉康复(speech and hearing rehabilitation, SHR)作为一个涉及医学、教育学、心理学、语言学等多学科交叉的领域，旨在帮助不同年龄段的个体克服沟通障碍，提升生活品质；提高SHR服务的覆盖率和服务质量，依赖于从业人员专业胜任力的提升。

高等职业院校SHR专业的建设是提升专业人员胜任力的重要举措[2]。在中国，“健康中国2030”战略的实施以及残疾预防和康复事业的发展，对高质量SHR专业人才，尤其是应用型、技能型人才提出巨大需求[3]。

高等职业教育承担着培养面向生产、建设、管理、服务一线高素质技术技能人才的使命[4]。近年来，中国政府大力推动职业教育改革，强调深化产教融合、校企合作，推行“岗课赛证”综合育人模式，旨在提升职业教育的适应性和吸引力[5-6]。然而，对于像SHR这样实践性极强、高度依赖临床经验和精密设备操作的专业而言，如何构建一个胜任力导向的高效教学系统，培养出真正具备岗位胜任力的专业人才，仍然是高等职业院校面临的严峻挑战。

传统的“课堂理论教学+简单实验+后期集中实习”模式往往难以满足SHR专业学生掌握复杂专业技能、培养临床思维和内化职业素养的需求[7]。校内实训基地，作为模拟真实职业环境的教学场所是解决这一问题的关键途径[8]。它不仅是理论知识转化为实践技能的“孵化器”，也是学生在进入真实临床环境前进行系统训练、降低风险、建立职业能力的关键。校内实训基地建设直接关系到办学质量与培养能力[9]。

本研究从构建胜任力导向的高等职业院校SHR教育体系视角出发，分析校内实训基地的构成和功能定位，基于世界卫生组织康复胜任力架构(rehabilitation competency framework, RCF)的方法，构建以胜任力导向的、模块化的实训模式和教学方法。

1 校内实训基地建设的意义与构成

校内实训基地是现代职业教育体系不可或缺的组成部分，其建设水平直接关系到人才培养质量。高等职业院校SHR专业强调培训学生的专业技能与专业能力，校内实训基地的意义尤为重大。

1.1 校内实训基地建设对发展SHR教育的战略意义

1.1.1 校内实训是高等职业教育的重要组成部分

校内实训作为高等职业教育体系的核心环节，通过“教-学-做”一体化的教学模式，可以有效解决SHR专业理论与实践脱节的关键问题。该专业特有的跨学科属性(医学、声学、语言学)和高精度设备依赖性(如符合国际声学标准的隔声室、喉频闪仪等)，决定了必须通过专业化的实训基地才能实现知识向技能的转化[10-11]。实训基地不仅构建了课程-实训-实习的有机衔接体系，更通过标准化操作流程(standard operating procedure, SOP)和高度仿真的临床环境(含虚拟/增强现实技术)，确保了评估与干预训练的规范性，同时弥合了不同实习单位间的条件差异，为职业资格认证和就业竞争力提升提供了重要保障。

1.1.2 发展校内实训是培养专业胜任力的关键环节

专业胜任力指从业者胜任特定职业所需的知识、技能、态度及价值观[12]。SHR工作涉及精细操作技能，如听力评估、言语/吞咽评估及干预、助听设备调试等[13]。实训基地通过标准化操作训练、案例分析、情景模拟等方式，帮助学生掌握核心技能，提升批判性思维与决策能力。

SHR工作对职业道德、人文关怀、沟通协作、法律法规意识要求极高[14]。实训基地通过模拟真实康复场景，使学生内化康复相关的伦理要求，培养学生的职业认同感、责任感和伦理意识[15]。

1.2 校内实训基地的构成要素

实训基地构成要素包括硬件设施、软件资源、人力资源和管理体系。教育部相关文件，如《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》[5]和《职业学校办学条件达标工程实施方案》[16]，也对实训基地的构成提出指导性要求。见表1。

中国知网 https://www.cnki.net

表1 SHR专业校内实训基地构成

Table 1 Components of the on-campus training base for SHR in vocational colleges

领域	构成要素	功能与专业特殊性要求	相关标准/政策参考
硬件设施系统	场地空间 功能分区 环境要求	听力区(隔声室、测听室、控制室)、言语评估区(录音/观察)、嗓音/吞咽/认知/儿童/成人康复训练室、助听技术室、情景模拟室、准备/消毒/资料/教研室等 听力区需符合声学标准(GB/T 16403),考虑无障碍设计、隐私保护	《职业学校办学条件达标工程实施方案》[16] GB/T 16403 (测听室声学标准) ASHA制定的《临床能力认证标准》[17]对临床设施的要求
	仪器设备 专业核心设备 辅助设备 仿真模拟设备	听力计、声阻抗、OAE/ABR、真耳分析、助听器编程器;标准化评估工具包、嗓音分析仪、生物反馈仪、AAC设备 计算机、摄录、模型;高仿真模拟人、虚拟/增强现实技术系统、标准化病人 设备应与行业主流技术同步,数量满足分组教学需求	教育部专业教学标准[18] ASHA/AAA设备指南,相关设备国家/行业标准
	安全设施	消防、水电安全、急救设备、操作规程、警示标识、网络安全 对涉及电生理、内窥镜模拟等操作有特殊安全要求	《高等学校实验室安全规范》[19],消防法规,电气安全规范
软件资源系统	实训教学资源 实训大纲/指导书 案例库 SOP 数字化资源	明确目标、内容、步骤、考核标准;覆盖常见病种的多样化案例;关键操作的标准化流程;在线仿真软件、教学视频、虚拟病人、文献数据库访问权限 资源需体现循证实践原则	教育部专业教学标准[18],ASHA循证实践门户,相关教材与专业指南
	信息管理系统 实训管理平台 教学资源平台 模拟电子病历	预约、设备管理、耗材追踪、过程记录、成绩统计;资源共享、在线学习;模拟临床记录操作	智慧校园建设相关要求
人力资源系统	“双师型”教师队伍	具备扎实理论基础和丰富临床经验;鼓励获得执业资格/认证;定期临床实践;能指导实训、开发案例、评价学生	《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》[20]
	行业专家/兼职教师	来自医院、康复中心、企业的资深专业人士;参与教学、提供前沿信息、指导项目	《职业学校校企合作促进办法》[21]
	实验技术人员	负责设备维护、调试、管理;协助教学准备;提供技术支持	-
	管理人员	负责基地日常运行、安全、制度执行、对外协调	-
管理体系	规章制度	准入、使用、安全、卫生、耗材、开放共享、档案管理等制度	学校相关管理规定
	运行机制 教学安排 开放共享 维护保养 经费保障	融入人才培养方案;服务校内、外培训;设备定期维护、校准、更新;稳定的经费投入与多元化筹资渠道	《职业教育提质培优行动计划》[5]

中国知网 https://www.cnki.net

续表

领域	构成要素	功能与专业特殊性要求	相关标准/政策参考
	评价与改进机制 教学效果评价 基地运行评价 持续改进	学生/教师/用人单位反馈;使用效率、管理水平评估;基于数据和反馈进行调整优化	ISO 9000质量管理体系原则[22]可借鉴
	产教融合机制	与医院、企业共建共享;共同开发课程/案例;师资互聘;技术服务	《职业学校校企合作促进办法》[21]《建设产教融合型企业实施办法(试行)》[23]

注：ASHA，美国言语语言听觉协会(American Speech-Language-Hearing Association)；AAA，美国听力学会(American Academy of Audiology)；OAE，耳声发射(otoacoustic emissions)；ABR，听觉脑干反应(auditory brainstem response)；AAC，辅助和替代沟通(augmentative and alternative communication)。

硬件设施包括场地设施和设备等。言语听觉专业的特殊性体现在对声学环境、专业设备精度和种类的高要求上。场地与设施等硬件建设需要严格遵守国家相关标准。

软件资源方面，高质量的教学资源库(如多样化的案例、标准化的操作视频、基于循证实践的干预方案示例)是实施有效教学的前提。信息管理系统能极大提升运行效率，实训管理平台有助于资源的合理调度和使用情况追踪，而模拟电子病历系统则能让学生提前熟悉临床工作流程。

人力资源系统需要打造“双师型”教师队伍，聘请行业专家作为兼职教师参与教学，配备专业的实验技术人员和管理团队，形成多元协同的教学力量。

管理体系是保障，确保实训基地安全、高效、可持续运行。完善的规章制度是规范师生行为、保障安全的基础。科学的运行机制，特别是与人才培养方案的紧密结合、有效的开放共享、常态化的维护保养和稳定的经费投入，决定了基地的使用效益。

2 校内实训功能模块构建

实训功能模块是承载校内实训内容和活动的基本单元，其设计的科学性、系统性和针对性直接影响学生的学习效果和发展专业胜任力。

2.1 校内实训模块构建的依据

ASHA制定的《临床能力认证标准》[17]详细规定了言语-语言病理学家和听力学家必须具备的知识和技能获取(knowledge and skills acquisition, KASA)表[24]。这些标准覆盖基础科学、专业理论、评估、干预、伦理、沟通、监督等多个维度，为识别核心能力和设计实训内容提供权威参照。例如，KASA标准中对听力评估技能(纯音、言语、声阻抗、OAE/ABR等的操作与解释)、言语样本采集与分析、各类障碍(构音、嗓音、流畅性、失语症、吞咽等)的评估与干预技术的具体要求，可以直接转化为实训模块的目标和活动[24]。

国际言语治疗和语音学协会(International Association of Logopedics and Phoniatrics, IALP)作为国际性学术组织，通过其教育指南倡导全球言语治疗和语音学教育的质量标准[25]。其指南虽不具有强制性，但强调循证实践、跨文化能力、终身学习等核心理念，并对课程内容、临床实践时数等提出建议，可作为实训模块设计理念和内容选择的重要参考。

中国教育部发布的《康复治疗技术专业教学标准(高等职业教育专科)》(以下简称《专业教学标准》)是实训模块设计的直接依据[18]。《专业教学标准》明确了该专业培养目标、职业面向、职业能力要求、课程体系以及实践教学要求。其中，“职业能力要求”部分详细列出学生应具备的专业核心能力(如听力检测与评估、助听技术应用、言语语言评估、常见言语语言障碍康复训练、吞咽障碍康复训练等)和可持续发展能力。这些能力要求应被分解、细化，并落实到具体的实训模块中。

2.2 校内实训模块构建原则

胜任力(能力)导向原则：实训模块的设计应以国家标准和参照ASHA等标准所确定的核心专业胜任力为出发点和归宿点，确保每个模块都明确指向一项或几项具体能力的培养[26]。

整合性原则：模块内容应与相关理论课程(如听力学基础、言语病理学、失语症学)紧密衔接，实现理论实践一体化。同时，要考虑与后续专业实践(实习)的对接，校内实训应为实习打好基础，实习中遇到的问题也可反馈到校内实训模块进行强化训练[27]。

中国知网 https://www.cnki.net

循序渐进原则：模块设置应遵循认知规律和技能习得规律，从基础到复杂，从单项技能到综合应用，从模拟环境到接近真实场景，逐步增加难度和复杂度，提供适当的“脚手架”支持[28]。

情境化原则：尽可能创设接近真实临床或工作场景的实训环境和任务，让学生在“做中学”，提高知识技能的迁移应用能力[29]。

标准化与个性化结合原则：核心技能的训练应遵循SOP，确保操作规范；同时，也要允许学生根据模拟案例的具体情况进行分析判断，体现一定的灵活性和个性化处理能力[30]。

2.3 高等职业院校SHR专业学生核心胜任力的分析

基于RCF，结合ASHA标准、国家标准及行业实际需求，可将高等职业SHR专业的核心专业胜任力分解为以下几个主要领域，并进一步细化为具体的知识、技能和态度要求。见表2。

2.4 基于学生胜任力架构实训模块设计

根据SHR专业教育的要求，校内实训课程采用模块化设计，形成8个知识模块。见表3。

表2　高等职业院校SHR专业核心胜任力

Table 2　Core competency of SHR major in higher vocational colleges

胜任力领域	核心能力点示例	对应的知识/技能/态度要求
专业基础与伦理	掌握相关基础科学知识 理解专业伦理规范与法律法规 展现专业精神与态度	解剖生理、声学、语言学、心理学基础；ASHA/AAA/国内伦理准则[31-32]；保密、知情同意、循证实践[33]；责任感、同理心、尊重差异、终身学习
听力评估	实施主观测听(纯音、言语) 实施客观测听(声阻抗、OAE、ABR等) 判读与解释听力学结果 撰写听力评估报告	掌握各种测听原理、设备操作、测试流程、结果判读标准[34]；了解影响因素与对策；具备规范记录与报告书写能力
听力康复与助听技术	实施听力康复咨询与指导 选配、调试、评估助听器效果 了解人工耳蜗等植入式设备 掌握听觉训练基本方法	听力损失对个体的影响；助听器原理、类型、验配流程[35]；真耳分析、声场评估；人工耳蜗基础知识；听觉康复策略
言语语言评估	实施各种言语(构音、嗓音、流畅度)、语言(理解、表达)、认知沟通、吞咽功能的评估 采集与分析言语样本 选择与使用标准化/非标准化评估工具 判读评估结果，进行初步诊断/分级 撰写评估报告	掌握各类障碍的评估方法、工具使用、结果解释[36]；熟悉常用量表；具备观察、访谈、测试、记录分析能力
言语语言干预	制定个性化康复计划 实施针对不同障碍(构音、嗓音、流畅、失语、发育迟缓、认知沟通、吞咽等)的康复训练 使用多种治疗技术与辅助手段(含AAC) 监测进展，调整计划 提供家庭指导与咨询	了解康复目标设定原则(SMART)；掌握主流干预技术与方法[37-38]；熟悉教具、软件、AAC设备使用；具备治疗记录与效果评估能力
沟通与协作	与服务对象及其家属有效沟通 与团队成员(医生、教师、其他康复师)协作 进行健康教育与科普宣传	掌握沟通技巧(倾听、共情、解释)；理解团队合作模式；具备一定的科普宣教能力

注：SMART，明确性(Specific)，可量化(Measurable)，可实现性(Achievable)，相关性(Relevant)，时限性(Time-bound)；

中国知网 https://www.cnki.net

表3　高等职业SHR专业校内实训模块构建

Table 3　Construction of in-school practical training modules for SHR in higher vocational colleges

模块名称	关联理论课程	主要对接实习岗位/内容	核心能力指向	核心实训活动	主要资源	建议学时
模块一:听力检测基础操作	听力学基础 医学声学	医院听力中心、体检中心助理岗	主观测听设备操作、流程执行、结果记录	纯音听阈测试SOP学习与演练;设备(听力计)识别、连接、校准(模拟);分组操作练习;结果记录与初步判读练习	纯音听力计、隔声室、模拟人头或同学互测	16~24
模块二:客观听力检测入门	听力学基础 听力障碍评估	医院听力中心、新生儿听力筛查岗	客观测听设备操作、结果识别	声阻抗、OAE、ABR(筛查型)设备介绍与演示;模拟测试操作;典型结果图形识别与初步解释(正常/异常)	声阻抗仪、OAE仪、ABR仪(或其模拟软件/教学模型)	16~24
模块三:助听器验配初步	助听器学 听力康复学	助听器验配中心验配助理岗	助听器类型识别、基本操作、验配流程了解	常见助听器类型识别与功能介绍;耳模制作观摩/模拟;编程软件界面熟悉;模拟验配流程演练(问诊、测听、选型建议);真耳分析/助听器分析仪演示	各类型助听器样品、编程器与软件、真耳分析仪(或模拟器)、耳印模材料与工具	24~32
模块四:标准化言语语言评估工具应用	言语病理学 失语症学 儿童语言障碍	医院康复科、特教机构评估岗	常用标准化量表(如WAB、BDAE简版、S-S法、R-CADE、儿童语言发育量表)的选择、施测、评分、解释	针对模拟案例(文字/视频)选择合适量表;分组进行施测演练(角色扮演);评分练习与信度核对;结果解释与报告片段撰写	各类标准化评估量表套件、指导手册、录音设备、标准化病人或详细案例	32~40
模块五:构音与嗓音障碍评估与干预模拟	语音学 构音障碍学 嗓音障碍学	医院康复科、嗓音门诊	构音/嗓音评估方法应用;基础干预技术模拟操作	构音评估(如图片命名、模仿说)与分析练习;嗓音评估(如VHI问卷、声学/气动分析软件操作);常用构音/嗓音矫治技术(如发音部位指导、呼吸训练、共鸣训练)演示与模仿练习	构音评估图片/词表、录音设备、嗓音分析软件、解剖模型、教学视频、生物反馈设备(可选)	32~40
模块六:吞咽障碍筛查与基础训练模拟	吞咽障碍学 神经病学基础	医院康复科、神经内科病房	吞咽障碍床边筛查方法;基础康复训练技术模拟操作	洼田饮水试验、冰刺激等筛查方法演练;口颜面肌肉运动训练、吞咽手法(如Mendelsohn法、声门上吞咽法)模拟练习;食物性状分级了解;安全喂食注意事项讨论	压舌板、棉签、小勺、不同性状模拟食物(凝胶、稠化剂)、教学模型/视频、FEESST模拟器(可选)	24~32
模块七:综合案例分析与康复计划制定	所有专业核心课程	各类临床/康复机构实习岗	整合信息、分析问题、制定计划、初步沟通	提供复杂(听力+言语/语言/吞咽)模拟案例(含评估结果);分组讨论,分析主要问题,确定康复目标(SMART原则),设计初步康复计划(短期/长期);进行模拟病例讨论会(MDT形式);练习与模拟家属沟通解释计划	详细的图文/视频案例资料、康复计划模板、相关文献/指南	24~32

中国知网 https://www.cnki.net

续表

模块名称	关联理论课程	主要对接实习岗位/内容	核心能力指向	核心实训活动	主要资源	建议学时
模块八:职业素养与沟通技能演练	康复心理学 专业伦理	所有实习岗位	伦理困境应对;困难沟通处理;团队协作模拟	伦理案例讨论(如知情同意、保密冲突);角色扮演:与焦虑/质疑/不合作的“家属”沟通;模拟团队交班/会诊;模拟科普宣教(如爱耳/爱嗓知识)	伦理案例集、标准化病人或经过培训的扮演者、沟通技巧指南	16~24

注:WAB,西部失语症成套测验(Western Aphasia Battery);BDAE,波士顿诊断性失语症检查(Boston Diagnostic Aphasia Examination);S-S法,符号-指称关系测验(Sign-Significate Relations Test);R-CADE,汉语失语症成套测验修订版(Revised Chinese Aphasia Examination);VHI,嗓音障碍指数问卷(Voice Handicap Index);MDT,多学科团队(Multidisciplinary Team);FEESST,纤维喉镜吞咽评估感觉测试(fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing with sensory testing)。

3 校内实训模块的教学

根据不同的实训模块目标和内容，学生和教师应灵活选用或整合多种学习与教学模式，典型的模式有以下几种。

3.1 问题导向学习

以真实的或模拟的复杂专业问题(如一个多重障碍的案例)驱动学习过程[39]。适用于培养临床思维、信息整合和团队协作能力的综合性实训模块(如模块七)。

3.2 案例教学法

围绕具体案例进行分析、讨论、决策[40]，适用于评估诊断、康复计划制定的训练(如模块四、七)。

3.3 模拟教学

利用模拟设备(听力计、虚拟现实系统)、模拟环境(隔声室、模拟诊室)、标准化病人等创设逼真的实践场景[41]。是技能操作(模块一至六)和沟通、应急处理(模块八)训练的核心模式。

3.4 项目导向学习

学生围绕一个具体的项目(如设计一个社区听力保健方案、开发一个简单的工具)进行学习和实践[42]。有助于培养综合应用能力和创新意识。

3.5 翻转课堂模式

将知识传授(如操作流程视频、理论讲解)移至课前，实训课堂则聚焦于互动、答疑、实践操作和能力应用[43]。适用于需要较多预备知识的实训模块。

4 结论

校内实训是高等职业院校SHR治疗专业教育的重要环节，是建立以专业胜任力为导向的高等职业教育体系的重要措施，高等职业院校校内实训基地建设涉及硬件设施和设备、软件、教师以及管理等4个领域。

基于言语听觉专业胜任力架构和核心知识、技能和能力结构，本研究构建了校内实训8大核心模块，并且提出了系统性的教学方案。校内实训模块的内容设计需与理论课程教学、校外专业实践形成紧密呼应和支撑，形成“课程-实训-实习”一体化的高等职业院校人才培养体系。校内实训模块的教学和学习，可以采用问题导向学习、案例教学法、模拟教学、项目导向学习以及反转课程等教学模式，并结合示范、练习、角色扮演、反思实践、有效反馈等多种教学策略，促进学生创造性学习并且发展专业胜任力。

利益冲突声明：所有作者声明不存在利益冲突。

[参考文献]

[1] World Health Organization. World report on vision [M]. Geneva: World Health Organization, 2019.

[2] 梁永胜,梁斐,展慧玲,等. 基于世界卫生组织康复胜任力架构开发高等职业院校言语听觉康复技术专业核心课程:理论架构和方法 [J]. 中国康复理论与实践, 2024, 30(11): 1241-1247.

LIANG Y S, LIANG F, ZHAN H L, et al. Developing core curricula of speech-language hearing rehabilitation technology in vocational colleges based on WHO rehabilitation competency framework: conceptual framework and approaches [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2024, 30(11): 1241-1247.

[3] 中国残联,教育部,民政部,等. 关于印发"十四五"残疾人康复服务实施方案的通知[A/OL]. (2021-08-16) [2025-01-22]. https://www.gov.cn/zhuanti/2021-08/20/content_5650192.htm.

[4] 周静,丁忠冰,钟凯颖,等. 发展基于世界卫生组织康复胜任力架构的言语听觉康复技术专业高等职业教育体系[J]. 中国康复理论与实践, 2024, 30(9): 993-1002.

ZHOU J, DING Z B, ZHONG K Y, et al. Developing an education system for speech language-hearing rehabilitation technology in higher vocational colleges based on WHO rehabilitation competency framework [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2024, 30(9): 993-1002.

中国知网 https://www.cnki.net

[5] 教育部,国家发展改革委,工业和信息化部,等. 教育部等九部门关于印发«职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)»的通知[A/OL]. (2020-09-16)[2025-01-10]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/29/content_5548106.htm.

[6] 新华社. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发«关于深化现代职业教育体系建设改革的意见»[A/OL]. (2022-12-21)[2025-02-10]. https://www. gov. cn/zhengce/2022-12/21/content_5732986.htm.

[7] American Speech-Language-Hearing Association. 2020 Standards and Implementation Procedures for the Certificate of Clinical Competence in Speech-Language Pathology [S/OL]. (2020-01-01)[2025-01-10]. https://www.asha.org/Certification/2020-SLP-Certification-Standards/.

[8] 林诚,潘燕霞,陈秀云,等. 以胜任力和创新力为导向的康复治疗学专业多元化实训教学体系的构建及实践[J]. 中国康复医学杂志, 2022, 37(6): 813-815.

LIN C, PAN Y X, CHEN X Y, et al. Construction and practice of diversified practical training teaching system of rehabilitation therapy specialty guided by competence and innovation [J]. Chin J Rehabil Med, 2022, 37(6): 813-815.

[9] WANG X. Concept, orientation and system mechanism: the construction of on-campus training base from the essence of vocational education [J]. OALib, 2022, 9(2): 1-6.

[10] STEEL J, COLUCCIO I, ELBOURN E, et al. How do speech-language pathologists assess and treat spoken discourse after TBI? A survey of clinical practice [J]. Int J Lang Commun Disord, 2024, 59(2): 591-607.

[11] GUAN H, XU Y, ZHAO D. Application of virtual reality technology in clinical practice, teaching, and research in complementary and alternative medicine [J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2022, 2022(3): 1373170.

[12] 邱卓英,郭键勋,孙宏伟,等. 世界卫生组织康复胜任力架构及其在康复领域的系统应用:理论架构、方法和应用领域[J]. 中国康复理论与实践, 2022, 28(3): 265-274.

QIU Z Y, KWOK J K F, SUN H W, et al. Systematic implementation of World Health Organization rehabilitation competency framework in rehabilitation: conceptual framework, approaches and application [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2022, 28(3): 265-274.

[13] 孙文,梁永胜,张瑜,等. 构建基于世界卫生组织康复胜任力架构的言语听觉康复高等职业教育课程体系[J]. 中国康复理论与实践, 2024, 30(9): 1003-1010.

SUN W, LIANG Y S, ZHANG Y, et al. Construction of curriculum system of higher vocational education in speech-language-hearing rehabilitation based on WHO rehabilitation competency framework [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2024, 30(9): 1003-1010.

[14] 张青,李彦群,贾文蓉,等. 听力障碍和言语障碍儿童保健、康复和教育服务的国际政策架构、核心内容与优先领域研究[J]. 中国康复理论与实践, 2024, 30(4): 373-380.

ZHANG Q, LI Y Q, JIA W R, et al. Research on framework, core content and priority areas of international policy of healthcare, rehabilitation and education services for children with hearing and speech impairments [J]. Chin J Rehabil Theory Pract, 2024, 30(4): 373-380.

[15] AJEMBA M, IROANYA J. Effectiveness of simulation-based training in medical education: assessing the impact of simulation-based training on clinical skills acquisition and retention: a systematic review [J]. World J Adv Res Rev, 2024, 21: 1833-1843.

[16] 中华人民共和国中央人民政府. 教育部等五部门关于印发«职业学校办学条件达标工程实施方案»的通知[A/OL]. (2022-11-02) [2025-01-22]. https://www. gov. cn/zhengce/zhengceku/2022-11/19/content_5727868.htm.

[17] American Speech-Language-Hearing Association. 2020 Standards and Implementation Procedures for the Certificate of Clinical Competence in Audiology [A/OL]. (2020-01-01)[2025-01-02]. https://www.asha.org/certification/2020-Audiology-Certification-Standards/.

[18] 中华人民共和国教育部. 康复治疗技术专业教学标准(高等职业教育专科)[S/OL]. (2025-02-11)[2025-03-11]. http://www. moe. gov. cn/s78/A07/zcs_ztzl/2017_zt06/17zt06_bznr/bznr_zyjyzyjxbz/gdzyjy_zk/zk_yywsdl/yywsdl_kfzll/202502/P020250207539797507117.pdf.

[19] 教育部办公厅. 教育部办公厅关于印发«高等学校实验室安全规范»的通知[A/OL]. (2023-02-14)[2025-03-22]. http://www. moe. gov. cn/srcsite/A16/moe_784/202302/t20230220_1045998.html.

[20] 教育部,国家发展改革委,财政部,等. 教育部等四部门关于印发«深化新时代职业教育"双师型"教师队伍建设改革实施方案»的通知[A/OL]. (2019-09-23)[2025-02-24]. http://www.moe. gov. cn/srcsite/A10/s7034/201910/t20191016_403867. html.

[21] 教育部,国家发展改革委,工业和信息化部,等. 教育部等六部门关于印发«职业学校校企合作促进办法»的通知[A/OL]. (2018-02-12)[2025-01-27]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/s7055/201802/t20180214_327467.html.

[22] 国际标准化组织. 国际标准:ISO9000 质量管理体系 基础和术语[S/OL]. (2015-09-15)[2024-12-25]. https://seatone. cn/news/upfile/10-ISO9000-2015%E5%9F%BA%E7%A1%80%E5%92%8C% E6%9C% AF% E8%AF% AD(% E4%B8%AD%E6%96%87%E7%89%88).pdf.

中国知网 https://www.cnki.net

[23] 国家发展改革委,教育部. 国家发展改革委 教育部关于印发«建设产教融合型企业实施办法(试行)»的通知[A/OL]. (2019-03-28) [2025-01-22]. https://www. gov. cn/zhengce/zhengceku/2019-12/01/content_5435044.htm.

[24] American Speech-Language-Hearing Association. Knowledge and skills acquisition (KASA) summary form for certification in audiology [EB/OL]. (2018-06-14) [2025-02-10]. https://hesp. umd. edu/sites/hesp. umd. edu/files/KASA_AUD_newstandards_July2016.pdf.

[25] Revised IALP education guidelines (September 1, 2009): IALP Guidelines for initial education in speech-language pathology [J]. Folia Phoniatr Logop, 2010, 62(5): 210-216.

[26] MCMULLEN J, ARAKAWA N, ANDERSON C, et al. A systematic review of contemporary competency-based education and training for pharmacy practitioners and students [J]. Res Social Admin Pharmacy, 2023, 19(2): 192-217.

[27] SALEEM M, KHAN Z. Healthcare simulation: an effective way of learning in health care [J]. Pak J Med Sci, 2023, 39(4): 1185-1190.

[28] FRANCOM G. Ten Steps to Complex Learning: a systematic approach to four-component instructional design (3rd ed.), by Jeroen J. G. van Merriënboer and Paul A. Kirschner [J]. Tech Trends, 2018, 62(7): 204-205.

[29] HALLMARK B, BROWN M, PETERSON D T, et al. Healthcare Simulation Standards of Best Practice™ professional development [J]. Clin Simul Nurs, 2021, 58(2): 5-8.

[30] American Speech-Language-Hearing Association. Joint Audiology Committee clinical practice statements and algorithms [A/OL]. (2023-04-20)[2025-03-01]. https://www.asha.org/policy/GL1999-00013/.

[31] American Speech-Language-Hearing Association. Code of ethics [S/OL]. (2023-03-01) [2025-02-20]. https://www. asha. org/code-of-ethics/.

[32] 国家卫生健康委办公厅. 国家卫生健康委办公厅关于印发康复治疗专业人员培训大纲(2023年版)的通知[A/OL]. (2023-10-27) [2025-02-11]. https://www. gov. cn/zhengce/zhengceku/202311/content_6915265.htm.

[33] GREENWELL T, WALSH B. Evidence-based practice in speech-language pathology: Where are we now? [J]. Am J Speech Lang Pathol, 2021, 30(1): 186-198.

[34] IEC. IEC 60645-1 Electroacoustics – Audiometric equipment – Part 1: equipment for pure-tone and speech audiometry [S/OL]. (2017-03-01) [2025-01-23]. https://standards. globalspec. com/std/10149761/iec-60645-1.

[35] The American Academy of Audiology. Guidelines for the audiologic management of adult hearing impairment [S/OL]. (2021-05-07)[2025-01-23]. https://www.audiology.org/wp-content/uploads/2021/05/haguidelines. pdf_53994876e92e42.70908344.pdf.

[36] American Speech-Language-Hearing Association. Preferred practice patterns for the profession of speech-language pathology [S/OL]. [2024-12-25]. https://www.asha.org/policy/PP2004-00191/.

[37] 世界卫生组织. 康复胜任力架构[M]. 邱卓英,郭键勋,孙宏伟,等,译. 中国康复理论与实践, 2022, 28(3): 249-264
World Health Organization. Rehabilitation competency framework [J]. QIU Z Y, KWOK J K F, SUN H W, et al., trans. Chin J Rehabil Theory Pract, 2022, 28(3): 249-264.

[38] World Health Organization. Rehabilitation competency framework [M]. Geneva: World Health Organization, 2020.

[39] BURDA A N, HAGEMAN C F. Problem-based learning in speech-language pathology: format and feedback [J]. Contemporary Issues Commun Sci Disord, 2015, 42(Spring): 47-71.

[40] LIM J J, VEASUVALINGAM B. Does online case-based learning foster clinical reasoning skills? A mixed-methods study [J]. Future Healthc J, 2025, 12(1): 100210.

[41] ABULFARAJ M M, JEFFERS J M, TACKETT S, et al. Virtual reality *vs*. high-fidelity mannequin-based simulation: a pilot randomized trial evaluating learner performance [J]. Cureus, 2021, 13(8): e17091.

[42] World Health Organization. Community-based rehabilitation: promoting ear and hearing care through CBR [M]. Geneva: World Health Organization, 2012.

[43] CHEN K S, MONROUXE L, LU Y H, et al. Academic outcomes of flipped classroom learning: a meta-analysis [J]. Med Educ, 2018, 52(9): 910-924.

(收稿日期:2025-04-14)

中国知网 https://www.cnki.net